CÓDIGO 6 — DE LA SALUD

Versión: V1.9
Alineación declarada: Constitución V.37; Código 1 V1.11; Código 2 V1.8; Código 3 V1.9; Código 4 V1.10; Código 5 V1.7; Código 7 V1.9; Código 8 V1.6; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.3; Código 10 V1.7; Código 11 V1.5; Código 12 V1.7; Código 13 V1.8; Código 14 V1.9; Código 15 V1.11; Código 16 V1.9.

TÍTULO PRELIMINAR — PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 1 — Objeto y naturaleza jurídica

1. El presente Código regula la protección de la salud como bien común de infraestructura, derecho inviolable y condición material de existencia de la Confederación, según el artículo 1.2 de la Constitución.
2. La salud no es una mercancía, una prestación de pago ni un privilegio vinculado a la posesión de competencias o a la cantidad de CBO realizada.
3. A efectos del presente Código, se entiende por salud el bienestar físico, psíquico, relacional y ambiental de la persona. Su evaluación respeta la autodeterminación individual y considera las condiciones colectivas que influyen en la salud.
4. El presente Código regula:
    a) la prevención de los riesgos relacionados con la CBO, los Almacenes y los hábitats;
    b) la vigilancia sanitaria y la coordinación con la seguridad de las tareas;
    c) la atención primaria, el cuidado de las personas frágiles y la salud mental;
    d) la gestión de los accidentes y de las enfermedades profesionales;
    e) la Cesta de Salud y la autonomía farmacéutica;
    f) la confidencialidad de los datos sanitarios.
5. Las competencias del presente Código se coordinan con las de los Códigos 12 y 14. El Consejo de Salud no sustituye a los órganos competentes en materia de seguridad general, cuidado de las personas frágiles o protección de los datos.

Art. 2 — Principios

1. **Prevención.** Las actividades de CBO, producción, logística y aprendizaje se organizan de modo que se prevengan los daños a la salud antes de que se produzcan.
2. **Autodeterminación.** Cada persona decide sobre su propio cuerpo y sobre su propio itinerario de atención sobre la base de un consentimiento libre, informado y revocable. Para los menores y para quien no está en condiciones de decidir se aplica el artículo 2-ter. Las medidas colectivas del artículo 2-bis pueden limitar tareas, actividades y desplazamientos dentro de los límites allí establecidos, pero nunca comprenden un tratamiento sanitario impuesto. Queda a salvo el artículo 8 para la persona temporalmente incapaz en crisis aguda.
3. **No culpabilización.** La enfermedad, el accidente y la fragilidad no constituyen culpa y no pueden conllevar, por sí mismos, una reducción de la Cesta de Suficiencia, la exclusión o una sanción. Se aplican las garantías del Código 4.
4. **Proximidad.** La atención se organiza, en la medida de lo posible, en el Círculo, en el Almacén y en el hábitat de la persona. El recurso a servicios hospitalarios o centralizados se dispone cuando es necesario para acceder a competencias de Nivel 3 no disponibles localmente.
5. **No mercantilización del saber.** Se prohíbe patentar o someter a muro de pago el saber que salva vidas y el conocimiento sanitario esencial. Se prohíbe la renta derivada del monopolio de competencias sanitarias, según el Código 5, artículo 8.

6. **Proporcionalidad y confidencialidad.** Toda medida sanitaria se limita al fin para el que se adopta. La información sanitaria se trata solo en la medida necesaria y con las garantías del artículo 11.

Art. 2-bis — Riesgo colectivo inmediato y coordinación con el artículo 8

1. Se entiende por **riesgo colectivo inmediato y documentado** una situación en la que un agente patógeno, un contaminante o una condición ambiental, sobre la base de evidencias científicas verificables y registradas en el Almacén del Saber de Salud, conlleva un peligro concreto, actual y grave de propagación o de daño a terceros, que no puede evitarse con medidas menos invasivas.
2. La comprobación se inicia a propuesta del Consejo de Salud y requiere:

   a) un dossier que describa las evidencias, el riesgo, las personas o los grupos potencialmente expuestos y las alternativas consideradas;

   b) el dictamen de al menos dos personas con competencia de Nivel 3, independientes y que no pertenezcan al Círculo proponente;

   c) la validación de la STV aplicable, cuando esté prevista.
3. Las medidas colectivas las delibera la Asamblea General según el procedimiento de urgencia del Código 3. La deliberación se motiva y documenta la necesidad, la proporcionalidad, la duración, las alternativas menos invasivas y los criterios de cese. La coordinación con el Código 14 se aplica cuando están implicados aspectos de seguridad general o de interrupción de actividades.

3-bis. Las medidas colectivas pueden comprender exclusivamente:

a) la información pública, las recomendaciones y la oferta gratuita de pruebas, vacunaciones, profilaxis y EPI, que siguen siendo voluntarias;

b) la protección indicada por la deliberación, entre vacunación, profilaxis, pruebas y EPI, como condición para realizar las tareas y para frecuentar los lugares de riesgo, en las condiciones del apartado 3-ter;

c) la suspensión o la reorganización temporal de actividades colectivas, reuniones, turnos de CBO, movilidad no esencial y hospitalidad no urgente;

d) el aislamiento de las personas contagiosas y la cuarentena de las personas expuestas, en las condiciones del apartado 3-quater;

e) las medidas sobre ambientes, agua, alimentos y bienes contaminados y, para las zoonosis, las medidas sobre los animales admitidas por el Código 13.

Solo son de riesgo las tareas y los lugares en los que el contagio puede afectar a personas especialmente expuestas: las salas y los consultorios, el cuidado de las personas frágiles conforme al Código 12 y, cuando el riesgo afecta a la infancia, los espacios para la infancia y los lugares de aprendizaje colectivo. Nadie puede ser excluido de la atención que necesita ni de la asistencia a una persona hospitalizada de cuyo cuidado es responsable; en estos casos se adoptan precauciones alternativas.

3-ter. Ninguna medida comprende un tratamiento sanitario, una extracción, una prueba o una vacunación realizados sobre el cuerpo de una persona sin su consentimiento o, para quien no puede decidir por sí mismo, sin el de quien decide conforme al artículo 2-ter. Quien rechaza la protección indicada conforme al apartado 3-bis, letra b):

a) puede ser excluido, durante la vigencia de la medida, solo de las tareas y de los lugares de riesgo;

b) recibe sin demora otra tarea compatible, computada en la CBO; si no hay ninguna disponible, se aplica la suspensión temporal del artículo 11, apartado 1, letra c), del Código 1. Al menor excluido de un espacio colectivo se le garantizan el cuidado y el aprendizaje de otra forma;

c) conserva la Cesta, la vivienda, la atención sanitaria, el voto, la participación deliberativa y los demás derechos, también durante la medida;

d) no comete infracción; el rechazo no se anota ni se comunica más allá de lo necesario para aplicar la letra

a).

3-quater. El aislamiento y la cuarentena:

a) se realizan en la vivienda de la persona o, si esta lo prefiere o la vivienda no lo permite, en un espacio adecuado puesto a disposición por el Círculo 1;

b) duran lo que indica el dossier del apartado 2 para el agente de que se trate y en ningún caso más de catorce días por persona y por exposición; una prórroga, por no más de otros catorce días, solo se admite si dos personas con competencia L3 certifican que la persona sigue siendo contagiosa o, para la cuarentena, que el periodo de incubación indicado por el dossier no ha concluido. Más allá de veintiocho días, el aislamiento de la persona que sigue siendo contagiosa y no lo consiente solo puede disponerlo el Tribunal de Garantía, después de haberla escuchado con las garantías del artículo 25, apartado 4, del Código 4, previa certificación de dos personas L3 independientes conforme al apartado 2, letra b), por periodos no superiores a catorce días y no más allá de la duración de la medida colectiva; en su defecto se aplica solo el apartado 3-ter;

c) si la persona no los consiente, los dispone individualmente el Consejo de Salud mediante acto motivado, comunicado sin demora al Tribunal de Garantía, que los convalida, los modifica o los revoca en un plazo de veinticuatro horas conforme al artículo 34, apartado 2, del Código 4; a falta de convalidación, cesan. La misma convalidación se aplica a la prórroga. No se aplica el apartado 3 del mismo artículo;

d) garantizan a la persona la entrega de la Cesta, la atención sanitaria, los contactos a distancia con sus seres queridos, el voto a través de la Red y la suspensión temporal de la CBO prevista en el artículo 11, apartado 1, letra c), del Código 1, salvo las tareas que la persona pida realizar a distancia;

e) no se hacen cumplir por la fuerza, salvo la intervención del Cuerpo de Tutela Cívica dentro de los límites del artículo 8-ter del Código 14; la convalidación de la letra c) vale también a efectos del apartado 4 de ese artículo;

f) durante la transición, si la persona no los consiente, solo pueden disponerlos las autoridades sanitarias del Estado, conforme al artículo 37 del Código 4.

3-quinquies. Durante toda la vigencia de la medida, el Consejo de Salud proponente publica, al menos cada semana, el dossier del apartado 2, los datos agregados y anónimos en los que se funda la medida, su evolución y las razones de cada renovación o cese, respetando el artículo 11.

4. La medida:

   a) dura como máximo treinta días;

   b) solo puede renovarse con una nueva deliberación y nueva documentación;

   c) se limita a lo estrictamente necesario y adopta la medida menos invasiva adecuada;

   d) la reexaminan, a petición de cualquier miembro, en un plazo de siete días, los integrantes de los Círculos de Garantía sorteados conforme al artículo 17, apartado 1-bis, del Código 3; el aislamiento y la cuarentena dispuestos individualmente siguen en cambio la convalidación del apartado 3-quater, letra c);

   e) se registra con su motivación, duración y criterios de cese, respetando la confidencialidad y los niveles de acceso previstos en los Códigos.

5. Cuando desaparecen los presupuestos, la medida cesa inmediatamente. La renovación no puede fundarse en la sola inercia ni en la falta de conclusión de un reexamen.

6. El presente artículo regula medidas de salud pública dirigidas a la colectividad. El artículo 8 regula las intervenciones individuales de emergencia sanitaria relativas a una persona en crisis. Los dos regímenes tienen objeto, presupuestos y procedimientos distintos y no se acumulan, salvo que estén documentadas ambas condiciones.

7. Las medidas adoptadas conforme al presente artículo no pueden reducir, ni siquiera durante su aplicación, la Cesta, la vivienda, la atención sanitaria, el voto y la participación deliberativa, ni producir efectos permanentes sobre el acceso a la CBO o a los demás derechos. Cualquier efecto adicional requiere un procedimiento autónomo previsto en los Códigos competentes y sus garantías.

8. Al cesar la medida se restablece la situación jurídica anterior de la persona. Los actos necesarios para documentar, verificar o someter a auditoría la medida pueden conservarse, con acceso limitado y según las garantías de confidencialidad del artículo 11.

Art. 2-ter — Consentimiento de los menores y de las personas que no pueden decidir

1. Desde que cumple dieciséis años, la persona presta, rechaza y revoca por sí misma el consentimiento a su propia atención sanitaria, conforme al artículo 2, apartado 2. Si, antes de cumplir dieciocho años, no está en condiciones de decidir, se aplica el apartado 2.

2. Hasta que el menor cumple dieciséis años, el consentimiento lo presta quien tiene la responsabilidad de su cuidado conforme al artículo 24.3 de la Constitución, después de haberlo informado y escuchado de modo adecuado a su edad. La opinión del menor tiene un peso creciente con la edad y la madurez, conforme al artículo 26.2 de la Constitución. Si las personas responsables son varias, deciden de común acuerdo; para la atención urgente basta el consentimiento de una de ellas. La responsabilidad de cuidado y el consentimiento del presente apartado no desaparecen por el solo cese de la condición de miembro de la persona responsable conforme al artículo 29, apartado 6-bis, del Código 4. Si nadie ejerce la responsabilidad de cuidado, o ninguna persona responsable puede ser localizada a tiempo, el consentimiento lo presta el representante temporal nombrado conforme al artículo 7-bis, apartado 5, del Código 12, hasta la decisión del Tribunal de Garantía prevista en el apartado 3-bis del mismo artículo. Quien presta el consentimiento por el menor no puede consentir una medida coercitiva: solo se aplica el artículo 8.

3. En caso de desacuerdo entre el menor y quien tiene la responsabilidad de su cuidado, o entre varias personas responsables, o de conflicto de intereses entre estas y el menor, pueden dirigirse al Tribunal de Garantía el menor, cada persona responsable, el profesional sanitario que lo atiende o el Consejo de Cuidado. El Tribunal obtiene el dictamen escrito de una persona con competencia sanitaria L3, independiente y no implicada en la atención, sorteada de la lista del artículo 36, apartado 1, letra b), del Código 4; escucha al menor, asistido por la persona de confianza prevista en el artículo 31.5 de la Constitución, y a las personas responsables; decide en un plazo de siete días o, si la atención no puede esperar, de veinticuatro horas, según el interés del menor y teniendo en cuenta su opinión conforme al apartado 2. Cuando la espera expondría al menor a un peligro para la vida o a un daño grave e irreversible, la atención necesaria se presta de inmediato, conforme al artículo 28.2 de la Constitución, y se informa al Tribunal.

4. Las vacunaciones y las profilaxis de los menores siguen los apartados 1 a 3 y nunca son obligatorias. El rechazo de una vacunación no constituye, por sí solo, negligencia grave ni perjuicio conforme al artículo 7-bis del Código 12. Durante una medida del artículo 2-bis, el menor que no tiene la protección indicada solo puede ser excluido de los lugares de riesgo, en las condiciones del apartado 3-ter de ese artículo.

5. Cuando una persona adulta no está en condiciones de decidir sobre su propia atención sanitaria por una condición que dura, o que se prevé que durará, más de sesenta días, comprobada por dos personas con competencia sanitaria L3 independientes, el Tribunal de Garantía nombra un representante estable, si la persona no lo ha designado conforme al artículo 7-bis, apartado 4, del Código 12. El representante se elige según el orden del artículo 7-bis, apartado 5, del Código 12 y decide según el apartado 6 del mismo artículo. La persona es informada y escuchada en la medida en que puede expresarse. El Tribunal reexamina el nombramiento al menos cada doce meses y en cualquier momento a petición de la persona, de la persona de confianza, del representante o del Consejo de Cuidado; cesa cuando la persona recupera la capacidad. Al desacuerdo o al conflicto de intereses entre el representante y la persona se aplica el apartado 3. El representante no puede consentir medidas coercitivas, reguladas únicamente en el artículo 8.

6. Durante la transición el presente artículo se aplica dentro de los límites que permite la ley vigente sobre el consentimiento de los menores y sobre la representación de las personas incapaces.

CAPÍTULO I — ORGANIZACIÓN, FICHAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Art. 3 — Consejo de Salud

1. Cada Círculo 1 instituye un Consejo de Salud compuesto por entre tres y siete miembros, con competencias de Nivel 2 o 3 en el ámbito sanitario, del cuidado, agroecológico o de la seguridad en el trabajo. Es la articulación local del Círculo de Competencia Medicina y Salud. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden volver a ser sorteados en el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato.
2. El Consejo de Salud:

   a) gestiona el Almacén de Salud y la Cesta de Salud a que se refiere el artículo 10;

   b) redacta y actualiza, para los aspectos sanitarios de su competencia, las Fichas de Seguridad de las tareas de CBO;

   c) organiza la vigilancia sanitaria, la gestión de los EPI de competencia sanitaria y la formación L1 sobre la salud;

   d) registra y analiza accidentes, cuasi accidentes y enfermedades profesionales;

   e) coordina el cuidado de las personas frágiles y las intervenciones de salud mental según el Código 12;

   f) coordina con los demás Círculos 1 la gestión de las competencias escasas y de las emergencias vitales, según el artículo 32 del Código 1 y el Código 14.
3. El Consejo de Salud no dispone de poderes de asignación sobre los bienes ni de poderes disciplinarios. No puede denegar ni condicionar el acceso a la Cesta.
4. El Consejo formula propuestas, documenta los riesgos sanitarios, organiza la asistencia y ejerce las funciones que le atribuye el presente Código. Sus decisiones se adoptan según el método del consenso previsto en el Código 3 y quedan trazadas.
5. Para cada tarea de CBO se designa un referente de seguridad con competencia L2, validada según el Código 5. El referente no sustituye al Consejo de Salud ni al Consejo de Seguridad previsto en el Código 14.

Art. 4 — Fichas de Seguridad, EPI y coordinación con el Código 2

1. Ninguna actividad de CBO puede realizarse sin una Ficha de Seguridad vigente, preparada según las STV aplicables y coordinada con los Códigos 1 y 14.
2. Cuando una tarea presenta aspectos sanitarios y de seguridad general, la Ficha puede ser única e integrada o estar compuesta por documentos vinculados con el mismo identificador y la misma versión. El Consejo de Salud valida los aspectos sanitarios; el Consejo de Seguridad valida los aspectos de seguridad general; el Consejo de Almacén valida los aspectos organizativos de su competencia. Ningún Consejo puede modificar los parámetros atribuidos a los demás.
3. La Ficha contiene al menos:

   a) los riesgos específicos;

   b) los EPI y las protecciones colectivas necesarios;

   c) los procedimientos operativos;

   d) los errores típicos y las medidas para prevenirlos;

   e) las condiciones de suspensión;

   f) las referencias a las STV aplicables;

   g) los límites de exposición y las pausas requeridas;

   h) la formación mínima necesaria;

i) la fecha, la versión, los responsables y las condiciones de revisión.

4. Los EPI son bienes comunes y se proporcionan gratuitamente. Los sujetos competentes para su custodia y su aprovisionamiento los mantienen accesibles, en buen estado y trazados. La falta de un EPI crítico previsto en la Ficha conlleva la suspensión inmediata de la actividad afectada y no constituye una infracción imputable a la persona a quien no se ha proporcionado el EPI. La obligación de disponer los EPI corresponde al Círculo responsable de la actividad.

5. Cada miembro puede interrumpir una actividad cuando detecte un riesgo grave e inmediato para sí o para otras personas. La interrupción se comunica lo antes posible al responsable operativo y al Consejo competente; no puede dar lugar a represalias si se realiza de buena fe. Se aplican el Código 14 y, para la continuidad logística, el artículo 32, apartado 3, del Código 1.

6. La STV de un bien incluye los aspectos de seguridad sanitaria relativos a la producción, el uso, el mantenimiento y la eliminación. La STV se coordina con la Ficha de Seguridad y no la sustituye cuando esta se requiere para una tarea específica.

Art. 5 — Vigilancia sanitaria, voluntariedad y condiciones de seguridad

1. La vigilancia sanitaria es voluntaria como itinerario general de atención y prevención. Para las tareas determinadas conforme al apartado 2, una evaluación de aptitud puede constituir un requisito técnico para la realización autónoma de esa tarea específica; no constituye una obligación sanitaria general.

2. Se aplican las siguientes reglas:

   a) para las actividades de CBO de riesgo nulo o bajo no se requiere un reconocimiento obligatorio;

   b) para las actividades de riesgo medio o alto, clasificadas según las STV y la Ficha de Seguridad, la evaluación de aptitud solo se requiere cuando es necesaria para la seguridad de la tarea autónoma;

   c) la evaluación de aptitud no es condición para acceder a la Cesta, participar en las deliberaciones o pertenecer a la Comunidad;

   d) quien rechaza el reconocimiento necesario para una tarea de riesgo medio o alto no realiza de forma autónoma esa tarea específica, pero conserva la Cesta de Suficiencia, el acceso a las demás tareas de CBO compatibles y el derecho a una tarea alternativa adaptada. El rechazo no constituye infracción y no se registra como anotación perjudicial;

   e) el reconocimiento periódico previsto para una competencia sanitaria L3 de alto riesgo puede ser condición para mantener la validación correspondiente, según el artículo 4, apartado 5, del Código 5. El rechazo conlleva, si es necesario, la suspensión de la validación específica, no una sanción.

3. Las evaluaciones sanitarias pueden comprender:

   a) un reconocimiento inicial para las tareas de riesgo medio o alto, cuando sea necesario conforme al apartado 2;

   b) un reconocimiento periódico para las competencias L3, al menos bienal o anual en caso de exposición continuada, según las STV aplicables;

   c) un reconocimiento solicitado por la persona en cualquier momento;

   d) un reconocimiento posterior a un accidente o a una enfermedad profesional.

4. El juicio es descriptivo y se limita a la tarea afectada. Puede indicar:

   a) aptitud;

   b) aptitud con adaptaciones;

   c) aptitud con limitaciones temporales;

   d) suspensión temporal preventiva de la tarea, con mantenimiento de la Cesta y propuesta de una tarea de CBO alternativa.

5. La falta de aptitud definitiva para una tarea específica solo puede declararla un Colegio de Reexamen externo según las garantías del Código 4, artículo 17. El Colegio está compuesto por:

   a) una persona con competencia sanitaria L3, sorteada y que no pertenezca al Círculo de la persona

interesada;

b) una persona del Consejo de Calidad no implicada en el procedimiento;

c) una persona sorteada entre los miembros de la Asamblea de un Círculo 1 distinto del afectado, con función de garantía procedimental.

6. Antes de la decisión, el Colegio obtiene el dictamen escrito de dos personas con competencia sanitaria L3 independientes, no implicadas en los juicios anteriores y, cuando sea pertinente, con especializaciones distintas. Las personas que emiten el dictamen no forman parte del Colegio y no participan en la decisión.

7. Ningún integrante del Colegio puede haber emitido un juicio de aptitud anterior sobre la misma persona y la misma tarea. Los dictámenes se ponen a disposición de la persona interesada antes de la decisión, salvo las limitaciones estrictamente necesarias para proteger datos sanitarios de terceros.

8. La decisión se motiva y queda trazada. Contra la falta de aptitud definitiva cabe recurso, en un plazo de catorce días, ante un nuevo Colegio externo, compuesto por personas distintas. El recurso se admite por:

a) vicio de procedimiento;

b) manifiesta irrazonabilidad técnica;

c) discriminación;

d) desproporción manifiesta.

Se aplican el Código 4, artículo 17, y el Código 5, artículo 9. El Colegio de segundo grado no puede agravar la situación de quien recurre.

9. Durante el procedimiento de comprobación de la falta de aptitud definitiva, la persona conserva la Cesta de Suficiencia y recibe una propuesta de tarea de CBO alternativa compatible.

10. Ningún dato sanitario puede usarse para limitar el acceso a las deliberaciones, a la Cesta o al aprendizaje.

CAPÍTULO II — CUIDADO, FRAGILIDAD Y SALUD MENTAL

Art. 6 — Atención primaria y Almacén de Salud

1. Cada Almacén dispone de un Almacén de Salud y de una Cesta de Salud mínima. La lista de la Cesta de Salud y la dotación mínima del Almacén de Salud las proponen los Consejos de Salud en coordinación federada, como articulaciones del Círculo de Competencia Medicina y Salud, mediante una STV adoptada conforme al artículo 3-bis del Código 2, y las aprueba la Asamblea con el Anexo Técnico previsto en el artículo 18, apartado 2, del Código 1. La Cesta comprende al menos:

a) medicamentos esenciales para salvar vidas;

b) material de primeros auxilios;

c) EPI de competencia sanitaria;

d) instrumentos de diagnóstico básicos;

e) documentación y STV sanitarias validadas.

2. La atención primaria se organiza mediante la tutoría y los consultorios de Círculo, con la participación de competencias L2 y L3. La persona elige entre las competencias disponibles, también de otros Círculos.

3. La IA prevista en el Código 7 puede apoyar la indexación de los protocolos, la búsqueda de información y los recordatorios. No puede formular de forma autónoma diagnósticos, determinar la aptitud ni decidir el tratamiento.

4. Cuando una competencia no está disponible localmente, el Consejo de Salud activa la red entre Círculos y el Registro de Dependencias previsto en el Código 15. Las medidas posibles comprenden:

a) el envío de la persona al servicio competente;

b) el envío temporal de la competencia al Círculo afectado;

c) la teletutoría supervisada por una persona L3, cuando sea apropiada y segura.

5. La modalidad elegida respeta la voluntad de la persona, la confidencialidad sanitaria y la continuidad de la atención.
6. La protección de la salud se articula en los tres niveles integrados del artículo 28.1 de la Constitución: la IA personal desconectada con función preventiva, según el artículo 5-bis del Código 7; los profesionales sanitarios de la Comunidad de Base; los centros de alta especialización del Círculo 3.

Art. 7 — Fragilidad, interdependencia y cuidado

1. Las personas mayores, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas, las personas embarazadas o en el periodo posterior al parto y las personas en duelo o en situación de crisis tienen derecho a una tutela reforzada y, cuando sea necesario, a la modulación de la CBO conforme al artículo 11 del Código 1 y al Código 12.
2. El cuidado de las personas frágiles forma parte de la CBO de la Lista A. En la jerarquía del artículo 32 del Código 1, las prestaciones de la Cesta de Cuidado de los niveles 1 y 2 siguen la letra b) del apartado 1 y el Código 12; las demás actividades de cuidado siguen la letra d) y preceden a la gestión de los bienes perecederos, conforme al apartado 1-ter del mismo artículo.
3. Las actividades de cuidado no pueden aplazarse por carencias logísticas ni por la gestión de los bienes perecederos, salvo que lo exijan las prioridades del artículo 32, apartado 1, letras a) y b), del Código 1, incluida la distribución de los alimentos de la Cesta. La decisión de aplazamiento se motiva y debe prever, cuando sea posible, una medida sustitutiva.
4. Todo Plan CBO incluye una cuota de cuidado y de tutoría. El cuidado no se considera una actividad residual que se realiza solo después de haber satisfecho las demás necesidades.
5. La modulación de la CBO no conlleva una reducción de la Cesta de Suficiencia ni anotaciones perjudiciales.

Art. 8 — Salud mental y protocolo para la crisis aguda

1. La salud mental es parte integrante de la salud. El malestar psicológico, el agotamiento profesional, el conflicto y el trauma no constituyen culpa ni debilidad individual.
2. El Consejo de Salud garantiza, directamente o mediante la coordinación con el Código 12:

   a) espacios de escucha;

   b) grupos de palabra;

   c) tutoría psicológica L2 o L3;

   d) la reducción temporal de la carga de CBO, cuando sea necesaria;

   e) el apoyo entre pares;

   f) el acceso a competencias especializadas sin lista de espera interna injustificada.
3. En caso de crisis aguda se aplica, como regla, un protocolo de protección no coercitivo, basado en:

   a) la presencia y la escucha;

   b) la puesta en seguridad relacional y ambiental;

   c) la propuesta de apoyo;

   d) la implicación, si la persona lo desea, de una persona de confianza designada por ella.
4. Una medida coercitiva inmediata solo se admite si concurren de forma acumulativa las siguientes condiciones:

   a) existe un riesgo vital inmediato y concreto para la persona o para terceros, documentado en ese momento por dos personas con competencia L3, al menos una de ellas sanitaria;

   b) la persona es temporalmente incapaz de expresar un consentimiento válido;

   c) no existe, de inmediato, una medida menos invasiva igualmente eficaz.

5. Cuando las dos competencias L3 no están inmediatamente disponibles, se activan sin demora los procedimientos de localización federada o de teletutoría previstos en el artículo 13 del Código 15. Mientras tanto solo se admiten medidas no coercitivas necesarias para la puesta en seguridad inmediata.

6. La intervención coercitiva que se adopte, en su caso:

   a) se limita al tiempo estrictamente necesario para evitar el riesgo vital;

   b) se realiza con la presencia de dos personas L3, cuando estén inmediatamente disponibles;

   c) se comunica sin demora al Tribunal de Garantía para la convalidación del apartado 7 y al Círculo de Garantía;

   d) se documenta en la Red con acceso regulado;

   e) se comunica a la persona de confianza designada, cuando sea posible;

   f) cesa inmediatamente cuando desaparecen los presupuestos.

7. En un plazo de veinticuatro horas desde el inicio de la medida, el Tribunal de Garantía, conforme al artículo 27, apartado 3, del Código 4, la convalida, la modifica o la revoca. Verifica los presupuestos del apartado 4, la necesidad y la proporcionalidad sobre la base de la documentación de las dos personas L3 y, cuando sea posible, después de haber oído a la persona, a su representante y a la persona de confianza. No realiza una evaluación clínica, que sigue siendo competencia de las personas con competencia sanitaria L3. A falta de convalidación dentro de plazo, la medida cesa. Si interviene el Cuerpo de Tutela Cívica, la convalidación del presente apartado sustituye a la prevista en el artículo 8-ter, apartado 4, del Código 14.

8. Después de la crisis se propone a la persona un itinerario de atención voluntario.

9. Se prohíben siempre la contención física punitiva, el aislamiento usado como sanción y la sedación punitiva.

10. La medida coercitiva:

    a) la reevalúan las dos personas L3 al menos cada doce horas y, durante la contención física, al menos cada hora; cada reevaluación se documenta;

    b) después de la convalidación dura como máximo setenta y dos horas y solo puede prorrogarse con una nueva convalidación del Tribunal de Garantía, solicitada antes del vencimiento sobre la base de una nueva certificación de dos personas L3, por periodos no superiores a setenta y dos horas; a falta de nueva convalidación antes del vencimiento, la medida cesa;

    c) no puede superar en total catorce días. Al vencimiento la medida cesa aunque el riesgo persista; se garantizan sin interrupción la presencia continuada de personas formadas, la puesta en seguridad relacional y ambiental del apartado 3 y la oferta de atención, y la persona puede permanecer voluntariamente en el lugar de atención. Solo se admite una nueva medida coercitiva por un nuevo episodio agudo, en las condiciones del apartado 4 certificadas por dos personas L3 distintas de las que certificaron la medida anterior, y con la convalidación de un Tribunal de Garantía en una composición distinta, que verifica expresamente que no se trata de la continuación de la medida cesada. En un periodo de noventa días las medidas coercitivas no pueden superar en total veintiocho días;

    d) la revoca en cualquier momento el Tribunal de Garantía, cuando desaparecen sus presupuestos, a petición de la persona, de su representante o de la persona de confianza; la solicitud se resuelve en un plazo de veinticuatro horas.

El representante no puede consentir una medida coercitiva en lugar de la persona: solo se aplica el presente artículo. Durante la transición no se ejecutan medidas coercitivas internas; toda intervención se limita a lo que permite la ley vigente y se alerta a los servicios de emergencia y a las autoridades sanitarias competentes, conforme al artículo 37 del Código 4.

11. Se prohíbe introducir etiquetas estigmatizantes en el Portafolio Personal.

Art. 8-bis — Documento de voluntades anticipadas y final de la vida

1. El documento de voluntades anticipadas es vinculante, conforme al artículo 27.3 de la Constitución. Lo redacta la persona, con la asistencia, si lo desea, de su propia IA personal desconectada y en presencia de dos testigos; se custodia en el Nodo personal y, si la persona lo desea, en el Consejo de Salud en forma reservada. Es revocable y modificable en cualquier momento.
2. Con el documento de voluntades anticipadas la persona puede designar a su propio representante para el caso de incapacidad, conforme al artículo 7-bis del Código 12.
3. Nadie puede ser sometido contra su voluntad a encarnizamiento terapéutico. Los cuidados paliativos y el alivio del dolor forman parte de la Cesta de Salud.
4. Se garantiza el derecho a permanecer en el domicilio, con el apoyo comunitario por turnos previsto en el Código 12. Las Casas Comunes autogestionadas son una elección de la persona y no pueden constituir un destino forzoso.

CAPÍTULO III — ACCIDENTES, MEDICAMENTOS, CONFIDENCIALIDAD Y AUTONOMÍA

Art. 9 — Accidentes, cuasi accidentes y enfermedades profesionales

1. Todo accidente, cuasi accidente o sospecha de enfermedad profesional se comunica y se registra sin demora. El registro operativo contiene solo la información necesaria para el análisis del suceso, entre otras:
   a) la descripción de lo ocurrido;
   b) la tarea realizada;
   c) la Ficha de Seguridad aplicable;
   d) los EPI y las protecciones disponibles;
   e) las condiciones operativas pertinentes;
   f) la fecha y la hora del suceso.
2. Los datos identificativos y sanitarios se conservan por separado y con acceso reservado según los artículos 7 del Código 14 y 11 del presente Código. La información publicada es agregada y anonimizada.
3. El análisis distingue, sin presumir automáticamente una responsabilidad individual:
   a) el desgaste o el caso fortuito, que conllevan la revisión de las STV y de la organización, sin responsabilidad individual automática;
   b) las carencias organizativas, que requieren la revisión de las medidas por parte del Círculo responsable y del Consejo de Salud;
   c) las conductas dolosas u otras conductas individuales relevantes, que se tratan según el Código 4.
4. La persona accidentada tiene derecho a la atención sanitaria, al mantenimiento de la Cesta y, durante la convalecencia, a la propuesta de una tarea de CBO alternativa adaptada, cuando sea compatible con su condición.
5. Los Consejos de Salud, en coordinación federada como articulaciones del Círculo de Competencia Medicina y Salud, realizan al menos trimestralmente un análisis agregado de los accidentes y de los cuasi accidentes para proponer la actualización de las STV del Código 2 y de las Fichas de Seguridad.
6. El ciclo de prevención comprende: el registro del suceso, el análisis de las causas, la actualización de las medidas, la revisión de las STV y la prevención de sucesos futuros.

Art. 10 — Cesta de Salud, medicamentos, fitoterapia y experimentación

1. La Cesta de Salud forma parte de la Cesta de Suficiencia prevista en el Código 1. Comprende bienes que salvan vidas cuya falta de disponibilidad puede determinar una emergencia vital de nivel 1.
2. La Confederación persigue la autonomía en la producción o en el aprovisionamiento federado de medicamentos esenciales no patentados y de dispositivos reutilizables, según las STV del Código 2. Las dependencias críticas de proveedores externos se inscriben en el Registro de Dependencias previsto en el Código 15.
3. Se entiende por **fitoterapia validada** un preparado vegetal acompañado de una STV vigente que indique al menos:

   a) la especie y la parte utilizada;

   b) la dosificación;

   c) las indicaciones y las contraindicaciones;

   d) las interacciones conocidas;

   e) las evidencias disponibles y sus límites;

   f) las modalidades de preparación y conservación.

El uso tradicional, por sí solo, no constituye validación. Cada preparado validado se inscribe en el Registro STV de Salud.

4. Se prohíbe la dependencia propietaria crítica de la que dependan medicamentos que salvan vidas, dispositivos de diagnóstico esenciales o EPI. Se aplican los artículos 4 y 5 del Código 2 y las disposiciones del Código 15.
5. No puede realizarse ninguna experimentación sanitaria sobre ninguna persona sin un consentimiento libre, informado, específico y revocable. El consentimiento se documenta por escrito después de haber proporcionado información comprensible sobre los riesgos, los beneficios, las alternativas y el derecho a retirarse.
6. La experimentación requiere previamente:

   a) la aprobación de un Colegio externo sorteado según el Código 4, artículo 17, compuesto por tres personas con competencia sanitaria L3 no implicadas en la experimentación;

   b) el dictamen del Círculo de Garantía sobre el consentimiento y sobre la proporcionalidad;

   c) la deliberación de la Asamblea General según el Código 3.
7. Se prohíbe la experimentación sobre menores, sobre personas en crisis aguda conforme al artículo 8 o sobre personas temporalmente privadas de la capacidad de expresar su consentimiento, salvo el caso excepcional en que esté dirigida a obtener un beneficio directo y específico para la propia persona. En tal caso deben concurrir de forma acumulativa todas las condiciones siguientes:

   a) el consentimiento prestado según el artículo 2-ter: para el menor, por él mismo si ha cumplido dieciséis años y, en caso contrario, por quien tiene la responsabilidad de su cuidado; para la persona incapaz, por el representante designado o nombrado conforme al artículo 7-bis del Código 12 o al artículo 2-ter, apartado 5. La persona de confianza no se considera representante, salvo que haya sido designada formalmente para esa función;

   b) si el representante no está disponible, la aplicación del procedimiento urgente previsto en el artículo 7-bis del Código 12 para la persona temporalmente incapaz, incluido el nombramiento urgente de un representante por parte del órgano competente;

   c) el dictamen favorable escrito de dos personas L3 independientes y no implicadas, que certifique el beneficio directo, la ausencia de alternativas de eficacia comparable y la proporcionalidad del riesgo;

   d) la autorización del Círculo de Garantía sobre los aspectos de consentimiento y proporcionalidad;

   e) la autorización del Tribunal de Garantía, que decide de forma reservada en un plazo de siete días o, si la atención no puede esperar, en un plazo de veinticuatro horas;

   f) la escucha y el respeto de la voluntad de la persona en la medida en que esté en condiciones de expresarla.

La falta de una sola de las condiciones impide el inicio de la experimentación.

8. Toda experimentación debe prever la trazabilidad, la cobertura de las responsabilidades colectivas, el acceso a la atención sanitaria para las posibles consecuencias y el derecho a retirarse de inmediato sin perjuicio.
9. La infracción de los apartados 5 a 8 constituye un vicio de procedimiento grave y conlleva la aplicación del Código 4, incluidos los efectos de invalidez y las obligaciones de reparación.

Art. 11 — Confidencialidad sanitaria y separación de los datos

1. La persona a la que se refiere el dato sanitario conserva su control. El Sistema fiduciario del Círculo ejerce funciones de custodia y de gestión técnica, sin poder utilizar los datos para finalidades propias o incompatibles.
2. El acceso a los datos sanitarios se regula del modo siguiente:

   a) el acceso ordinario corresponde a la persona interesada y a la persona de confianza designada por ella, dentro de los límites del consentimiento;

   b) el Consejo de Salud puede acceder a la información necesaria para la vigilancia sanitaria, limitándose, por regla general, a los juicios de aptitud y a las adaptaciones y no a los diagnósticos detallados;

   c) el Círculo de Garantía puede acceder a los datos necesarios para resolver un recurso, según un procedimiento trazado y con acceso limitado;

   d) a falta de consentimiento, el acceso del Consejo de Salud solo se admite cuando es necesario para ejecutar una medida colectiva válidamente deliberada conforme al artículo 2-bis. El acceso se limita a los datos estrictamente necesarios, es proporcionado y temporal, queda trazado y, cuando es posible, se comunica a la persona interesada. Cabe el reexamen del Círculo de Garantía en un plazo de siete días.
3. El Almacén del Saber contiene exclusivamente:

   a) Fichas de Seguridad sin datos sanitarios individuales;

   b) STV sanitarias anonimizadas;

   c) estadísticas agregadas sobre los accidentes;

   d) protocolos de atención validados.

No contiene datos sanitarios individuales.

4. Se prohíbe la publicación de datos sanitarios nominativos, de listas de patologías atribuibles a personas o de mapas individuales de fragilidad. La infracción constituye un vicio de procedimiento grave según el Código 4.
5. Toda persona tiene derecho:

   a) a obtener copia de sus propios datos sanitarios;

   b) a solicitar su rectificación;

   c) a solicitar su supresión cuando ya no sean pertinentes o necesarios;

   d) a solicitar la supresión o el olvido de episodios superados, salvo las medidas colectivas documentadas y válidamente deliberadas conforme al artículo 2-bis, limitándose a la información estrictamente necesaria.
6. La supresión o la rectificación del dato personal no conlleva la supresión de información ya anonimizada de forma irreversible y utilizada para estadísticas, análisis epidemiológicos o actualización de las STV. Los datos personales se mantienen separados de los datos estadísticos anónimos y no deben poder reconstruirse.

Art. 12 — Disposiciones transitorias y vínculos

1. El presente Código se coordina con:

a) el Código 1, artículos 27, 29, 31 y 32;

b) el Código 2, para las STV y la validación de los bienes;

c) el Código 3, para los procedimientos de urgencia y las deliberaciones;

d) el Código 4, artículo 17, para el Colegio de Reexamen y las garantías;

e) el Código 5, para las competencias L2 y L3, el artículo 4, apartado 2, letra c), el artículo 4, apartado 5, y el artículo 10;

f) el Código 12, para el cuidado de las personas frágiles;

g) el Código 14, para la seguridad general;

h) el Código 15, para el Registro de Dependencias.

2. Se aplica la validación provisional sanitaria prevista en el artículo 10 del Código 5. Quien ejerce una función sanitaria de alto riesgo en la fecha de entrada en vigor puede mantener una validación provisional:

a) durante seis meses para las funciones correspondientes al Nivel 3 del Código 5;

b) durante doce meses para las funciones correspondientes al Nivel 2 del Código 5.

Se requieren la inscripción en el itinerario de validación en un plazo de treinta días, la supervisión reforzada, el respeto de las STV y la trazabilidad de las actividades. Durante el periodo provisional la persona no puede validar las competencias de otras personas.

3. En un plazo de doce meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 pone en funcionamiento un Almacén de Salud mínimo y prepara las Fichas de Seguridad para las tareas sanitarias y de seguridad sanitaria clasificadas L3 y activas, según el Código 5, artículo 4, apartado 2, letra c).

4. Para las tareas L3 no sanitarias se aplican el Código 5 y el Código 14; el presente Código no regula su validación técnica.

5. En un plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor se realiza una auditoría federada sobre la autonomía farmacéutica y sobre los EPI, con inscripción de las dependencias críticas en el Registro de Dependencias del Código 15.